

Un patient de 40 ans connu pour un trouble bipolaire sans traitement vous consulte ce jour pour un état dépressif d'intensité relativement sévère avec tristesse, perte de plaisir, trouble du sommeil, sentiment de désespoir et de dévalorisation. Il présente également quelques idées suicidaires mais mentionne ne pas vouloir passer à l'acte. Le bilan de santé montre des tests hépatiques perturbés (élévation des transaminases). Le reste du status est normal.

Le traitement médicamenteux le plus approprié pour ce patient est

- A. carbamazépine
- B. haloperidol
- C. lithium
- D. diazepam
- E. sertraline

Une patiente de 20 ans vous consulte en raison de crises de colère qu'elle ne peut maîtriser surtout avec son petit copain. Elle dit de constamment craindre qu'il ne la quitte et se sent, dans ces moments, particulièrement mal. Souvent elle se cogne la tête contre les murs pour soulager sa détresse. Elle a ce genre de comportements depuis l'adolescence et dit ne pas savoir qui elle est vraiment. Elle souffre beaucoup et pense souvent à la mort. Toutefois, elle ne dit pas être triste et prend du plaisir à dessiner par exemple. Il n'y a pas de symptômes psychotiques. Le diagnostic le plus probable serait:

- A. Trouble de la personnalité borderline
- B. Trouble bipolaire de type 2
- C. Trouble bipolaire de type 1
- D. Trouble dépressif récurrent
- E. Schizophrénie

Une femme de 54 ans, connue un trouble bipolaire, se présente au mois de novembre pour un rendez-vous de suivi. Elle ne se sent pas triste en ce moment mais dit être souvent fatiguée et avoir froid. Elle a pris près de 13 kg en 6 mois. Elle essaie de faire de l'exercice, de manger un régime sain et promet qu'elle est prend son traitement de lithium. Sa tension artérielle est de 110/80 et sa fréquence cardiaque est de 65/min. A l'examen physique vous notez qu'elle est un peu ralentie psychiquement, mais le reste est normal. La prochaine étape, la plus appropriée, dans la prise en charge est de

- A. Prescrire du citalopram
- B. Prescrire du méthylphénidate
- E. Faire des tests thyroïdiens
- C. Débuter une luminothérapie
- D. Faire un test d'effort

Une femme de 31 ans se plaint que chaque automne elle se sent plus déprimée, fatiguée, ayant moins d'énergie et d'intérêt à faire certaines activités qui lui plaisent habituellement. Elle dit dormir plus et est somnolente toute la journée; elle mange également plus prenant jusqu'à 10kg pendant l'hiver. Ces symptômes se résolvent spontanément au printemps. Elle ne désire pas d'antidépresseur et souhaiterait savoir quel traitements alternatifs existent pour son problème. La réponse la plus appropriée en ce qui la concerne est

- A. Une thérapie basée sur la pleine conscience
- B. Du neurofeedback
- D. Des compléments vitaminiques (vitamines B12, B6, C et E)
- E. Des hormones thyroïdiennes (T4)
- C. De la luminothérapie

Un homme de 45 ans, connu pour un trouble dépressif récurrent traité par le passé avec succès par de la sertraline, se présente ce jour pour un nouvel épisode dépressif d'intensité moyenne. Il est d'accord de reprendre un traitement antidépresseur pour autant que ce dernier n'induisse pas de problèmes de libido ou d'érection.

La réponse la plus appropriée est:

- A. Considérer sa plainte et lui proposer du bupropion
- B. Ne pas considérer sa plainte et lui prescrire l'antidépresseur qui avait marché par le passé: la sertraline
- C. Considérer sa plainte et lui proposer de la paroxétine
- D. Considérer sa plainte et mais l'informer qu'il n'il n'existe pas d'antidépresseur sans effet sur la libido ou l'érection
- E. Considérer sa plainte et lui proposer de la venlafaxine

Un homme de 43 ans, sans antécédent médical ou psychiatrique connu, se présente aux urgences. Il raconte que depuis trois mois, il présente des épisodes subits de palpitations, dyspnée, sensation de « claustrophobie », et des paresthésies distales. Lors de l'examen, il vous paraît calme, mais affirme que plus tôt dans la matinée, il a fait une « attaque ». Sa tension artérielle est de 150/110 mmHg, et sa fréquence cardiaque est de 105/min. Le patient est en transpiration et a les pupilles dilatées. Les analyses toxicologiques urinaires reviennent positives pour la cocaïne. La prochaine étape, la plus appropriée, dans la prise en charge est de

- A. lui donner une prescription de lorazepam et un rendez-vous de suivi avec son médecin traitant
- B. lui donner une prescription de paroxétine et un rendez-vous de suivi dans une clinique psychiatrique
- C. lui fournir une thérapie par agoniste pour sa dépendance à la cocaïne
- D. lui recommander une thérapie cognitivo-comportementale et des exercices de relaxation
- E. le référer à un collègue pour le traitement de sa dépendance à la cocaïne

Un homme de 44 ans, VIH-positif, dépendant à l'héroïne, est amené aux urgences avec un délire paranoïaque que son propriétaire tente de l'empoisonner en envoyant un gaz toxique via le système de ventilation. Le patient n'est pas agité, n'exprime pas d'idéation suicidaire ou meurtrière, et n'a pas de plainte d'ordre dépressif. Son dossier montre que c'est la première fois qu'il délire. L'examen physique est sans particularité. Des analyses toxicologiques, une formule sanguine complète, la chimie sanguine, une ponction lombaire et un CT de la tête avec injection de produit de contraste sont sans particularité. Le patient est admis à l'unité de psychiatrie avec le diagnostic différentiel de trouble psychotique non spécifié versus psychose secondaire à l'infection VIH. Le traitement approprié pour ce patient est

- A. amitriptyline 200 mg au coucher
- B. diazepam 10 mg 4x/j
- C. trazodone 100 mg 3x/j
- D. methylphenidate 5 mg 1x/j
- E. olanzapine 5 mg 2x/j

Un homme de 45 ans est admis à l'étage en raison de changements électrocardiographiques observés après prise de cocaïne. À l'admission, le patient ne présente pas de signes de confusion, est orienté à tous les modes, et il n'a pas de plaintes d'anxiété ou de dépression récente. Lors de son deuxième jour d'hospitalisation, l'EKG est normal, et un infarctus du myocarde est exclu. Lorsque vous vous apprêtez à la faire sortir, il vous dit qu'il « se sent très déprimé et fatigué ». Il ajoute qu'il sent qu'il a « de la peine à bouger ». Il nie toute idéation suicidaire, sensation de culpabilité, paranoïa, ou troubles perceptifs. Ses signes vitaux sont stables. La prochaine étape, la plus appropriée, dans la prise en charge est de

- A. administrer de l'halopéridol pour traiter les symptômes psychiatriques et physiologique du sevrage à la cocaïne
- B. observer ses symptômes jusqu'à résolution du sevrage
- C. effectuer des tests neuropsychologiques pour évaluer la présence d'un trouble bipolaire
- D. se préparer à effectuer une thérapie électroconvulsive
- E. débiter une psychothérapie d'orientation analytique

Un homme de 56 ans, connu pour une dépendance à l'alcool souhaite quitter l'hôpital contre avis médical. Le patient a été admis 13 jours auparavant en raison d'une hémorragie sur ulcère gastrique et d'une pneumonie d'aspiration. Le patient est médicalement stable pour sortir, mais l'équipe médicale était à la recherche d'un placement dans une unité ambulatoire de traitement de dépendance à l'alcool. Le patient affirme actuellement qu'il ne souhaite pas un tel traitement. Il vous dit qu'il n'est ni déprimé ni suicidaire. Il n'y a pas d'hallucination ni de délires. Le patient, lorsqu'on lui pose la question dit qu'il ne souhaite pas entreprendre un traitement pour l'alcool. Cependant, il est d'accord d'avoir un suivi médical ambulatoire. La prochaine étape, la plus appropriée, dans la prise en charge est de

- A. permettre au patient d'être libéré à la condition qu'il soit emmené et interné dans un centre de désintoxication alcoolique
- B. permettre au patient de sortir contre avis médical et l'aiguiller vers un programme ambulatoire de traitement de sa dépendance à l'alcool
- C. obtenir une décision psychiatrique qui statue que le patient doit laisser l'hôpital le soigner et prendre des décisions de placement
- D. effectuer une sédation, contention physique, puis réévaluer le patient
- E. mettre le patient sous tutelle en raison de son trouble du jugement

Un homme de 31 ans est admis à l'hôpital pour un épisode maniaque aigu. Il est menaçant et des injections intramusculaires d'haloperidol sont nécessaires pour contrôler son agitation. Après une semaine d'hospitalisation, son agitation est contrôlée, et il ne présente plus que des symptômes d'hypomanie. Il a déjà été hospitalisé 3 fois par le passé pour des épisodes maniaques. Lors d'un colloque d'équipe, ses traitements d'haloperidol et de lithium sont discutés. Si le patient est laissé sous haloperidol, avec sa maladie bipolaire, il serait exposé à un risque accru de

- A. agranulocytose
- B. syndrome de Cushing
- C. démence de type Alzheimer
- D. hypophosphatémie
- E. dyskinésies tardives

Gary est un jeune de 19 ans qui s'est retiré de l'université après avoir eu des troubles du comportement au cours duquel la police a dû intervenir. En effet il avait enclenché toutes les alarmes du campus ce jour-là: *"J'ai pris la responsabilité de déclencher plusieurs alarmes incendie dans mon dortoir pour m'assurer qu'elles fonctionnaient, étant donné le caractère vital ou mortel des incendies ».*

Ces derniers temps, il avait changé d'orientation universitaire de l'ingénierie à la philosophie et avait de plus en plus réduit son sommeil, passant de longues heures à parler avec ses amis de la nature de la réalité. Il était convaincu de l'importance de ses idées, affirmant fréquemment qu'il était plus savant et plus avancé que tous ses professeurs. Il a dit aux autres qu'il était sur le point de révolutionner son nouveau domaine, et il est devenu de plus en plus irritable et intolérant envers tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il a également augmenté un certain nombre de comportements à haut risque - boire et avoir des relations sexuelles multiples et non protégées.

Les parents de Gary sont choqués par son attitude, ils reconnaissent que Gary a eu des problèmes précoces d'anxiété dans son enfance et de dépression pendant son adolescence mais ne comprennent pas ce qui vient de se passer.

De quel trouble Gary souffre-t-il?

Sarah est une femme de 23 ans qui a récemment été adressée à un psychiatre. La famille de Sarah rapporte qu'elle a eu des comportements bizarres au cours des six derniers mois. Avant l'apparition de ses symptômes, Sarah était connue pour être une personne extravertie et sociable qui aimait passer du temps avec des amis et participer à diverses activités sociales.

Sarah est devenue de plus en plus renfermée et isolée, passant souvent des heures seule dans sa chambre sans aucune interaction sociale. Son discours est également devenu désorganisé et difficile à suivre, avec de fréquents exemples de divagation et d'incohérence. De plus, elle a commencé à faire preuve de méfiance, croyant que les gens la regardent et parlent d'elle dans son dos.

Au départ, ils l'ont attribué au stress lié à ses activités académiques. Sarah était alors en dernière année d'université. Cependant, au fil du temps, les changements sont devenus plus prononcés et préoccupants. Sarah a commencé à exprimer des croyances bizarres, comme être capable de communiquer par télépathie avec des extraterrestres et de recevoir des messages secrets via la télévision. Elle a également développé des idées de référence, croyant que les objets et les événements quotidiens avaient des significations personnelles importantes.

Le fonctionnement social de Sarah a considérablement diminué depuis le début de ses symptômes. Auparavant membre active de sa communauté, elle s'est retirée de son cercle social et a cessé de s'impliquer dans les activités parascolaires. Elle a également eu du mal à maintenir ses résultats scolaires, manquant des devoirs et des examens en raison de la détérioration de son état.

De quel trouble Sarah souffre-t-elle?

Catherine est une femme de 28 ans qui souffre d'une détresse et d'un handicap important en raison de sa peur des situations où elle doit rencontrer des gens. Elle évite les interactions avec autrui autant que possible et se sent extrêmement anxieuse et gênée lorsqu'elle est au centre de l'attention. Elle s'inquiète excessivement d'être gênée ou humiliée devant les autres. En conséquence, elle a limité ses opportunités de carrière et a peu de relations proches. Ces symptômes persistent depuis au moins six mois et ne s'expliquent pas mieux par un autre problème de santé mentale.

De quel trouble Catherine souffre-t-elle?

Comportement

Sylvie me semble assez distrait et souvent dans la lune. Ses premiers résultats pourraient être meilleurs. S'en suit-ils absolument persuadée.

Alors ce courage, tu es grande maintenant !

Comportement

Sylvie me fait vraiment plaisir. Il me semble qu'elle "dérive" ses carnets écrits sur les meilleurs moments et de façon assez régulière.

Les notes qu'elle écrit sont vraiment très intéressantes. Il y a aussi des notes de la vie de la classe. C'est très bien et j'ai l'impression qu'elle se sent bien en classe et qu'elle est vraiment bien.

Remarques émanant de la 1^{re} semaine (comportement et travail)

Beaucoup trop d'agitation. Réagit à son travail. Attends les notes et doit se souvenir de s'écrire.

Signature de l'enseignant : C. Chavet

Remarques émanant de la 2^e semaine (comportement et travail)

Tes notes sont de qualité de ton travail, de plus, de ton manque de patience. Mais, de plus, de ton manque de patience. Mais, de plus, de ton manque de patience. Mais, de plus, de ton manque de patience.

Remarques émanant de la 3^e semaine (comportement et travail)

Tu es en SP. J'ai vu que cela te laisse l'occasion de mieux l'organiser dans ton travail. Mais, de plus, de ton manque de patience. Mais, de plus, de ton manque de patience.

Sylvie vient vous voir car elle se sent déprimée depuis quelques temps et n'arrive plus à faire son travail de gestionnaire RH. Après une anamnèse ciblée elle vous montre ses carnets scolaires car elle dit que pour elle les remarques qu'on lui faisait enfant ressemblent beaucoup aux difficultés qu'elle a actuellement.

En lisant ses carnets, de quel trouble pourrait-il s'agir?

Sophie est une femme de 30 ans qui présente des schémas relationnels instables et une instabilité émotionnelle significative. Elle a une peur intense de l'abandon et fait des efforts désespérés pour éviter tout sentiment d'isolement. Sophie a des difficultés à maintenir des relations amoureuses stables et elle se sent souvent vide et sans identité. Elle est sujette à des accès de colère incontrôlables et peut s'engager dans des comportements impulsifs, tels que des dépenses excessives ou des comportements suicidaires.

Quel est le symptôme central du trouble de la personnalité borderline, tel que décrit dans le cas de Sophie ?

- a) Schizophrénie
- b) Peur excessive des situations sociales
- c) Instabilité émotionnelle et des relations interpersonnelles
- d) Obsessions et compulsions récurrentes

Parmi ces affirmations concernant le trouble de stress post-traumatique (PTSD), une seule est juste

- A. Le PTSD peut survenir en l'absence d'un événement traumatique.
- B. Le PTSD n'arrive que chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques pré-morbides.
- C. Seul l'événement traumatique, lui-même, permet de prédire le risque de PTSD.
- D. Le PTSD ne fait pas toujours suite à un état de stress aigu.
- E. Le risque de PTSD diminue en cas de dissociation péritraumatique

Laquelle de ces propositions est juste concernant les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) :

- A) Le traitement de 1^{ère} ligne sont les antipsychotiques atypiques
- B) Les obsessions sont des pensées, des images ou des pulsions
- C) l'approche psychothérapeutique de choix est la psychothérapie systémique
- D) Age médian d'apparition : 35 ans
- E) critère diagnostic : durée >5h/ jour

Georges est un patient de 45 ans qui se présente amené par la police aux urgences en raison de problèmes de comportement. En effet ses voisins se sont plaint qu'il dérange énormément en faisant du bruit toute la nuit et n'ayant aucune considération pour eux ; ils le décrivent comme quelqu'un d'irritable et lorsque la police est arrivée il s'est montré violent et agressif envers eux. Lors de votre évaluation, le patient parle beaucoup, ne vous laisse pas l'interroger, il évoque avoir été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité, que Dieu lui parle toutes les nuits et c'est pour ça qu'il ne dort pas. Il semble agité, ne pas pouvoir tenir en place et vous êtes vite amené à devoir le contenir par la force. Ces proches présent lors de l'entretien vous mentionnent que c'est la première fois qu'il a un épisode de ce type et qu'il n'a jamais eu d'autres problèmes psychiatriques par le passé hormis un épisode de dépression traité il y a de cela quelques années en arrière. Au vu de ce qui précède le diagnostic le plus probable est :

- A. un trouble schizophrénique
- B. trouble dépressif récurrent
- C. un trouble bipolaire
- D. un trouble de la personnalité borderline
- E. un trouble anxieux.

Concernant la cinétique d'évolution de la schizophrénie, laquelle de ces affirmations est vraie:

- A. lors de la phase prodromique on retrouve habituellement déjà des symptômes de type hallucinations auditives ou visuelles
- B. la phase prodromique est plutôt rare dans l'émergence de la schizophrénie
- C. la phase prodromique marque souvent le début d'un isolement social et d'un désinvestissement de la vie scolaire
- D. la durée de psychose non traitée n'a pas d'impact sur le pronostic d'évolution de la schizophrénie
- E. la prévention secondaire précoce commence lors du diagnostic de premier épisode psychotique

Laquelle de ces propositions n'est pas un symptôme psychotique négatif?

- A. Aboulie
- B. Anhédonie
- C. Anosognosie
- D. Émoussement affectif
- E. Retrait social

- A. Deux (ou plus) parmi les symptômes suivants, chacun devant être présent dans une proportion significative de temps au cours d'une période d'un mois (ou moins en cas de traitement efficace). Au moins l'un des symptômes (1), (2) ou (3) doit être présent :
1. Idées délirantes.
 2. Hallucinations.
 3. Discours désorganisé (p. ex. incohérences ou déraillements fréquents).

4. Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique.

5. Symptômes négatifs (aboulie ou diminution de l'expression émotion).

- B. Durant une proportion significative de temps depuis le début du trouble, le niveau de fonctionnement dans un domaine majeur tel que le travail, les relations interpersonnelles ou l'hygiène personnelle est passé d'une façon marquée en dessous du niveau atteint avant le début du trouble (ou, quand le trouble apparaît pendant l'enfance ou l'adolescence, le niveau prévisible de fonctionnement interpersonnel, scolaire ou professionnel n'a pas été atteint).
- C. Des signes continus du trouble persistent depuis au moins 6 mois. Pendant cette période de 6 mois les symptômes répondant au critère A (c.-à-d. les symptômes de la phase active) doivent avoir été présents pendant au moins un mois (ou moins en cas de traitement efficace) : dans le même laps de temps des symptômes prodromiques ou résiduels peuvent également se rencontrer. Pendant ces périodes prodromiques ou résiduelles, les signes du trouble peuvent ne se manifester que par des symptômes négatifs, ou par deux ou plus des symptômes listés dans le critère A présents sous une forme atténuée (p. ex. croyances étranges ou expériences de perceptions inhabituelles).
- D. Un trouble schizoaffectif, ou dépressif, ou un trouble bipolaire avec manifestations psychotiques ont été exclus parce que 1) soit il n'y a pas eu d'épisode maniaque ou dépressif caractérisé concurremment avec la phase active des symptômes, 2) soit, si des épisodes de trouble de l'humeur ont été présents pendant la phase active des symptômes, ils étaient présents seulement pendant une courte période de temps sur la durée totale des phases actives et résiduelles de la maladie.

Laquelle de ces propositions est vraie concernant le diagnostic de la schizophrénie selon le DSM 5 ?

- A. Au moins 2 symptômes pendant une partie significative du temps pendant un mois, dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, symptômes négatifs, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique
- B. Au moins 2 symptômes pendant une partie significative du temps pendant un mois, dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs
- C. Au moins 2 symptômes pendant une partie significative du temps pendant six mois, dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, symptômes négatifs, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique
- D. Au moins 2 symptômes pendant une partie significative du temps pendant six mois, dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique, symptômes négatifs
- E. Au moins 3 symptômes pendant une partie significative du temps pendant six mois, dont au moins un des 2 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, symptômes négatifs, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique

Lequel de ces symptômes est indispensable pour poser un diagnostic de trouble dépressif :

- A. Diminution du plaisir
- B. Troubles du sommeil
- C. Ralentissement psychomoteur
- D. Sentiment de dévalorisation
- E. Troubles de la concentration

Laquelle de ces affirmations est juste concernant le traitement des épisodes dépressifs :

- A. En cas de non réponse au traitement antidépresseur, la première alternative est l'ajout d'un second antidépresseur de classe différente
- B. Les antipsychotiques typiques sont reconnus comme traitements d'augmentation des traitements antidépresseurs
- C. La psychothérapie n'est pas indiquée comme traitement de la dépression sévère
- D. La TMS (stimulation magnétique transcrânienne) est indiquée pour le traitement des épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques
- E. L'activité physique fait partie du traitement de la dépression

Rachelle est une jeune femme de 25 ans qui se présente aux urgences amenée par ses parents. Ces derniers évoquent que leur fille, suite à une rupture amoureuse, s'est mise en colère avec eux, est devenue insupportable. Ils n'en peuvent plus car elle menace de se suicider et de vouloir mettre fin à ses jours ; elle s'est dans ce contexte scarifié les avant-bras. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ceci et à chaque problème sentimental dans sa vie il en est ainsi. Ses parents voudraient savoir quelle est la meilleure solution pour aider leur fille. Après discussion avec cette dernière, celle-ci ne semble pas avoir d'antécédents médicaux notoire ni d'autres problèmes psychiatriques importants et n'a jamais été hospitalisée. Elle évoque des émotions qui vont dans tout les sens et ce depuis qu'elle est adolescente et avoir de la peine à les réguler particulièrement dans les relations amoureuses. Au vu de la situation décrite ci-dessus quelle est la meilleure option thérapeutique pour cette patiente.

- A. prise en charge psychothérapeutique pour le trouble en question
- B. antidépresseur au vu des idées suicidaires
- C. traitement neuroleptique la patiente ayant de toute évidence des troubles psychotiques
- D. stabilisateur de l'humeur à fin de réguler ses émotions
- E. benzodiazépines pour la calmer

Parmi les troubles ci-dessous lequel n'est habituellement pas associé à des symptômes psychotiques :

- A. trouble anxieux type phobie sociale
- B. trouble dépressif majeur épisode actuel sévère
- C. trouble bipolaire
- D. Schizophrénie
- E. trouble de la personnalité borderline

Une femme de 24 ans se présente aux urgences avec son bébé de 3 mois. Elle craint de lui faire du mal car depuis quelques semaines elle s'imagine de plus en plus souvent qu'elle va le blesser avec un couteau. Elle n'arrive pas à chasser ces pensées qui l'a font terriblement souffrir. Elle dit pourtant qu'elle aime son enfant et ne veut pas lui faire du mal. Elle a d'ailleurs éliminé tous les grands couteaux de sa cuisine. De quel symptôme s'agit-il le plus vraisemblablement?

- A. D'hallucinations
- B. D'un troubles du moi
- C. D'une dérégulation des émotions
- D. D'un délire de mort
- E. De pensées obsédantes

laquelle des propositions suivantes est fausse concernant l'évolution du trouble bipolaire :

- A. La survenue des épisodes thymiques est de moins en moins liée à des événements stressants
- B. Les modalités évolutives sont très variables
- C. L'évolution est habituellement marquée par une dégradation psychosociale
- D. La durée des phases de rémission tend à s'allonger
- E. La fréquence et la durée des phases dépressives tendent à augmenter avec l'âge